

 Pôle PMF	PRISE EN CHARGE D'UNE CHOLESTASE INTRA-HEPATIQUE GRAVIDIQUE		090 PMF 210 PTXX 003 Version 3 Page 1 / 2
	PROTOCOLE	PATHOLOGIES MATERNELLES ET FŒTALES	

1 – Concerne : les médecins, internes et sages-femmes du pôle Mère Femme.

2 – Application :

Tout prurit sans lésion éruptive durant la grossesse doit faire évoquer une cholestase gravidique.

Interrogatoire : localisation, rythme, intensité, prise médicamenteuse ou risque allergique, facteurs déclenchants.

Définition :

- Prurit évocateur : isolé, palmoplantaire, nocturne.
- Et élévation des sels biliaries > 10 $\mu\text{mol/L}$ à jeun ou augmentation des ALAT supérieurs à 2 fois la normale.
- Après élimination d'autres orientations étiologiques à l'examen clinique.

Premier bilan à réaliser :

- Bilan hépatique,
- NG, Bilan de coagulation,
- Sels biliaries prélevés à jeun.

Les signes de gravité sont :

- Sels biliaries supérieurs à 100 $\mu\text{mol/L}$.
- Ictère clinique (selles décolorées, urines foncées, ictère conjonctival).
- Ictère biologique (bilirubine totale > 30 $\mu\text{mol/L}$).

Prise en charge en anténatal :

➤ Prurit ET sels biliaries > 10 $\mu\text{mol/L}$ et < 40 $\mu\text{mol/L}$ ou ALAT > 2N :

- Hospitalisation initiale.
- Acide ursodésoxycholique (Delursan® ou Cholorso®) en première intention : 15 mg/kg/j en deux prises (matin et soir) jusqu'à l'accouchement.
- Anti-histaminique à discuter en cas de persistance du prurit sous Acide ursodésoxycholique :
 - Atarax® 25 mg 1 cp au coucher, à stopper lors d'une éventuelle décision de déclenchement si la patiente souhaite allaiter (Atarax déconseillé en cas d'allaitement, et demi-vie d'élimination plasmatique de 20 heures).
 - Cétirizine 1 cp le matin.
- Arrêt des éventuels traitements en cours si non indispensables.
- Conseils d'hydratation.

Intitulé et référence du document associé : aucun			
REDACON : 01/10/2024 Dr Camille NALLET - Médecin Gynécologues obstétriciens	VERIFICATION : Mohcine AICH Qualiticien – Direction Qualité	VALIDATION : Dr Astrid ECKMAN Gynécologue obstétricien	APPROBATION : Pr Nicolas MOTTET Chef de pôle PMF
Liste de diffusion : médecins, internes et sages-femmes du pôle Mère Femme via le logiciel institutionnel de gestion documentaire et le classeur virtuel de l'unité PMF.			
Relecture périodique du document - sans modification par :		le :	

- Echographie hépatique en cas de cytolysse avec ALAT > 2N +/- bilirubine totale > 30µmol/L.
- Surveillance en GHR 1 fois par semaine avec monitoring.
- Sels biliaires et bilan hépatique 1 fois par semaine.

→ Terme de naissance à discuter avec la patiente en fonction de la stabilité du bilan biologique sous traitement, de la tolérance du prurit maternel et de l'absence d'antécédent de mort fœtale in utero.

➤ Prurit ET sels biliaires entre 40 et 100 µmol/L :

- Hospitalisation initiale.
- Acide ursodésoxycholique (Delursan® ou Cholurso®) en première intention : 15 mg/kg/j en deux prises (matin et soir) jusqu'à l'accouchement.
- Anti-histaminique à discuter en cas de persistance du prurit sous Acide ursodésoxycholique :
 - o Atarax® 25 mg 1 cp au coucher, à stopper lors d'une éventuelle décision de déclenchement si la patiente souhaite allaiter (Atarax déconseillé en cas d'allaitement, et demi-vie d'élimination plasmatique de 20 heures).
 - o Cétirizine 1 cp le matin.
- Echographie hépatique en cas de cytolysse avec ALAT > 2N +/- bilirubine totale > 30µmol/L.

→ Discuter un déclenchement à partir de 37 SA et 39 SA+6j si persistance des sels biliaires > 40 µmol/L sous traitement chez une patiente symptomatique.

- Sortie autorisée en cas de décroissance de sels biliaires et amélioration des symptômes maternels.
- Suivi GHR 1 fois par semaine associé à un suivi par sage-femme libérale : 1 fois par semaine si sels biliaires entre 10 et 40 µmol/L et 2 fois par semaine si sels biliaires entre 40 et 100 µmol/L.
- Sels biliaires et bilan hépatique 1 fois par semaine.

➤ Prurit + sels biliaires supérieurs à 100 µmol/L :

- Hospitalisation Sels biliaires + bilan hépatique 2 fois par semaine.
- Bilan de coagulation 1 fois par semaine.
- Vitamine K 10mg/j PO pendant 15 jours si bilan de coagulation perturbé.
- 2 ERCF par jour.
- Acide ursodésoxycholique (Delursan® ou Cholurso®) : 15 mg/kg/j en deux prises (matin et soir) jusqu'à l'accouchement.
 - o Atarax® 25 mg 1 cp au coucher, à stopper lors d'une éventuelle décision de déclenchement si la patiente souhaite allaiter (Atarax déconseillé en cas d'allaitement, et demi-vie d'élimination plasmatique de 20 heures).
- Cétirizine 1 cp le matin.
- Corticothérapie à discuter si âge gestationnel inférieur à 34 SA.

→ Déclenchement à envisager à partir de 36 SA si persistance des sels biliaires > 100 µmol/L sous traitement. Avoir atteint une concentration > 100 µmol/L à un moment de la surveillance fait recommander d'induire la naissance à partir de 36SA.

 Pôle PMF	PRISE EN CHARGE D'UNE CHOLESTASE INTRA-HEPATIQUE GRAVIDIQUE		090 PMF 210 PTXX 003 Version 3 Page 3 / 2
	PROTOCOLE	PATHOLOGIES MATERNELLES ET FŒTALES	

Prise en charge dans le post partum :

Si allaitement maternel envisagé

- Si dernière prise d'Atarax® >48h avant la mise au sein → allaitement maternel autorisé
- Si dernière prise d'Atarax® <48h avant la mise au sein :
 - Durée du traitement < 48h → Allaitement maternel possible
 - Durée du traitement > 48h → tirer et jeter le lait pendant 48h
- Arrêt des traitements après l'accouchement.
- Surveillance de la disparition du prurit.
- Bilan hépatique à J2 sans dosage des sels biliaires.
- Prescription possible d'une contraception hormonale dès que le bilan hépatique est normalisé (contraception oestroprogestative autorisée : idéalement faiblement dosée en oestrogènes).
- Informer la patiente d'un risque de récurrence de cholestase au cours d'une grossesse ultérieure ou sous contraception oestroprogestative (contrôle du bilan hépatique 3 mois après le début de cette contraception).
- Bilan hépatique à 3 mois du post partum.
- Proposer une consultation avec un hépatologue pour discuter de la prise en charge de la grossesse suivante.